CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche IV - C - 6

Version 1.6.0

Du 01/09/2026

CONDUITE À TENIR

Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ

Accouchement inopiné

DÉFINITION

L'accouchement inopiné est l'acte de mettre au monde un nouveau-né hors d'une maternité. Il peut survenir avant l'arrivée des secours ou en leur présence.

Normalement, l'accouchement survient lors du 9ème mois de grossesse, soit entre 37 et 41 semaines révolues d'aménorrhée (absence de règles). Avant 37 semaines d'aménorrhée, on parle d'accouchement prématuré.

On appelle parturiente une femme enceinte lorsque le travail a commencé.

L'accouchement se déroule en 3 étapes.

1) Le travail (fig. 1)

À la fin de la grossesse, l'utérus commence à se contracter, de plus en plus régulièrement et de plus en plus fort. La partie basse de l'utérus commence à s'ouvrir pour pouvoir laisser passer l'enfant. L'ouverture se traduit par la sortie de glaires sanguinolentes (bouchon muqueux) puis du liquide dans lequel baigne le fœtus. Ce liquide est normalement clair. La rupture de la poche des eaux peut aussi survenir avant le début du travail.

Le travail peut durer de plusieurs minutes à plusieurs heures suivant la personne. Il est habituellement plus rapide chez une femme qui a déjà accouché une ou plusieurs fois.

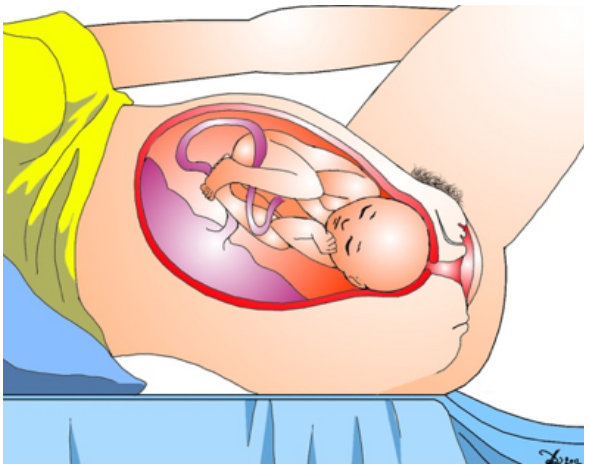


Figure 1 : Travail

2) L'expulsion (fig. 2)

L'orifice (col) de l'utérus s'ouvre de plus en plus sous l'effet des contractions. Le fœtus descend vers le vagin, en général la tête la première. Le nouveau-né apparaît alors et progressivement va sortir du corps de la mère. Une fois expulsé, le nouveau-né est toujours relié à la mère par le cordon ombilical. Le nouveau-né peut alors, après clampage et section du cordon ombilical, être pris en charge. L'expulsion peut durer plusieurs minutes.

L'enfant se présente normalement la tête en avant (présentation céphalique). Cependant d'autres présentations sont possibles (présentation par le siège ou l'épaule) et peuvent être source de complications parfois très graves (ralentissement de l'accouchement, impossibilité d'accoucher, sortie en premier et compression du cordon ombilical)

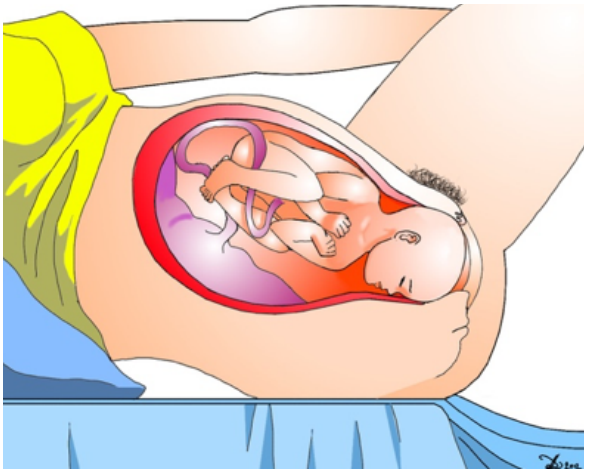


Figure 2 : Expulsion

3) La délivrance (fig. 3)

Il s'agit de la sortie hors de l'utérus du placenta, de la poche utérine et du reste du cordon ombilical (annexes). Généralement, elle survient dans les 30 minutes après la sortie du nouveau-né.

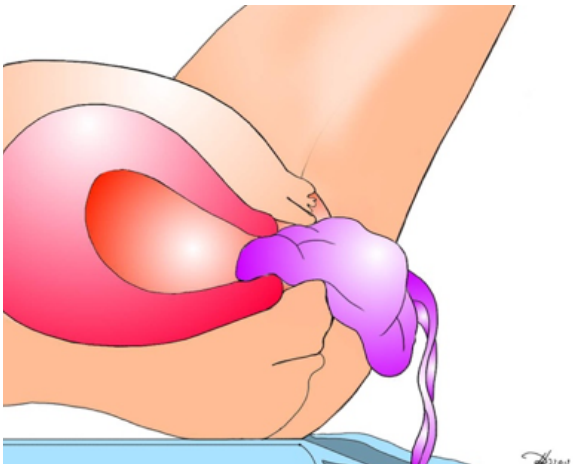


Figure 3 : Délivrance

CAUSES

Les causes d'accouchement inopiné sont multiples : grossesse mal ou non suivie, multiparité (plusieurs accouchements), antécédent d'accouchement rapide ou inopiné.

CONSÉQUENCES

L'accouchement se déroule normalement sans complication, mais il peut parfois entraîner des complications mettant en jeu la vie du fœtus et de la mère.

BILAN

Les signes d'une menace d'accouchement sont en règle générale très faciles à identifier lors du bilan de la victime.

Il s'agit d'une femme enceinte qui dit vouloir accoucher et qui se plaint :

- de douleurs abdominales (contractions) régulières, espacées au début puis de plus en plus fréquentes, intenses et rapprochées. Ces douleurs abdominales traduisent les contractions utérines et marquent, par leur apparition, le début du travail,
- d'une envie irrépressible de pousser,
- d'un écoulement de liquide normalement clair entre les jambes (la rupture de la poche des eaux). La rupture de la poche des eaux peut survenir alors que la mère ne présente aucune contraction utérine.

À l'examen, il peut être constaté :

- l'apparition de la tête du nouveau-né à la vulve,
- en posant doucement la main sur le ventre de la mère, la perception d'un durcissement suivi d'un relâchement du ventre durant la contraction,
- un enfant déjà né à notre arrivée.

Dans de rares cas, particulièrement dans le cadre de grossesses cachées ou refusées, le secouriste peut se trouver en présence d'une femme qui présente une « hémorragie vaginale ». Interroger la mère ou l'entourage, éventuellement inspecter les lieux à la recherche d'un nouveau-né qui est parfois caché.

Après l'expulsion (dans les 30 min après la sortie du bébé), l'apparition d'un léger saignement à la vulve (filet de sang) ou de nouvelles contractions utérines pouvant être accompagnées d'un envie de pousser, annoncent la délivrance.

PRINCIPES DE L'ACTION

- Réaliser un bilan complété par des éléments spécifiques de l'accouchement.
- Assister la parturiente pendant l'accouchement lorsqu'il n'est plus possible de la transporter à l'hôpital.
- Assurer une prise en charge et la surveillance attentive de la mère avant ou après l'accouchement.
- Prendre en charge le nouveau-né.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Matériel de premiers secours : lot A, B ou C.
- Lot « soins du cordon ombilical »

CONDUITE À TENIR

L'accouchement n'a pas encore eu lieu

- Installer la femme enceinte sur le côté, de préférence sur son côté gauche.
- Réaliser un bilan d'urgence vitale de la femme enceinte (Fiche III-C).
- Réaliser un bilan complémentaire (Fiche III-D) au cours duquel il convient à l'interrogatoire de la femme enceinte, de son entourage ou en consultant le carnet de maternité, de recueillir en plus les éléments spécifiques suivants :
  - la date et le lieu prévus de l'accouchement (à terme, prématuré),
  - l'heure du début des contractions, leur fréquence, leur régularité, la durée des contractions et l'intervalle entre deux contractions,
  - la perte de liquide (perte des eaux), l'heure de cette perte et la couleur du liquide (transparent, trouble, sanglant),
  - la perception par la mère de mouvements du foetus,
  - le nombre d'accouchements (parité), de grossesses et leur déroulement,
  - les particularités de la grossesse en cours : suivi ou non, simple ou multiple, malformation foetale connue,
  - les particularités de l'accouchement : voie basse ou césarienne, nature de la présentation si connue : tête, siège, épaule.
- Transmettre le bilan et les données recueillies pour obtenir un avis médical (Fiche III-F).

Ces données vont permettre au médecin régulateur d'évaluer l'imminence de l'accouchement et les risques de ce dernier.

Le transport de la parturiente peut être réalisé après avis médical

- Relever et installer la victime sur un brancard, allongée sur le côté, de préférence sur son côté gauche et ceinturée.
- Transporter la victime en milieu hospitalier.
- Surveiller la victime durant le transport (Fiche III-E).

L'accouchement doit avoir lieu sur place

- Préparer le matériel nécessaire à l'accouchement et à l'accueil du nouveau-né :
  - serviettes de bain propres et sèches,
  - récipient pour recueillir les liquides corporels et le placenta.
- Préparer une zone et le matériel nécessaire à une éventuelle réanimation du nouveau-né :
  - bouteille d'oxygène, insufflateur manuel pédiatrique,
  - aspirateur des mucosités avec une sonde adaptée au nouveau-né (Fiche V-C-12),
  - Appareil de mesure de la fréquence cardiaque et de la SpO_2 .
- Mettre des gants à usage unique et se protéger contre le risque de projection de liquide (masque, lunettes de protection) (Fiche V-H-5).
- Installer la parturiente dans la position qui lui convient le mieux (demi-assise, à quatre pattes, sur le côté, accroupie, debout, etc.) En cas de position demi-assise, il est préférable que la parturiente ait les fesses légèrement au-delà du bord du lit ou du brancard, avec les cuisses fléchies, de façon que le bassin soit partiellement dans le vide. » (fig. 4),

- Réaliser l'accouchement[1] :
  - Demander à la parturiente de pousser vers le bas en retenant sa respiration et, si possible, jusqu'au maximum de la contraction :
    - à partir du moment où le haut du crâne du nouveau-né commence à apparaître à la vulve,
    - lorsqu'elle ressent un besoin irrépressible de pousser.

    Deux à 3 poussées peuvent être réalisées par contraction.
  - En cas de position demi-assise demander à la parturiente d'attraper ses cuisses avec ses mains et de fléchir au maximum ses cuisses sur l'abdomen pendant la poussée (fig. 5)
  - faire reposer ou maintenir les jambes à la fin de la contraction utérine,
  - recommencer la même manœuvre jusqu'à l'apparition de la moitié de la tête du nouveau-né,
  - cesser alors de faire pousser la parturiente, laisser se terminer l'expulsion naturellement tout en ralentissant la sortie de la tête en la maintenant d'une main afin d'éviter les déchirures du périnée (fig 6)
  - accompagner progressivement la sortie spontanée du nouveau-né :
    - maintenir la tête du nouveau-né avec les deux mains sans s'opposer à sa rotation au cours de sa descente. Généralement la tête regarde vers le bas (fig. 7) puis effectue une rotation de 1/4 de tour sur la droite ou la gauche au cours de sa sortie (fig. 8),
    - une fois la tête totalement sortie ou si la tête ne tourne pas, demander à la parturiente d'arrêter de pousser et vérifier la présence ou non d'une circulaire du cordon autour du cou du nouveau-né. Le dégager si nécessaire (voir ci-après),
    - maintenir la tête du nouveau né le temps du dégagement des épaules qui sortent l'une (épaule antérieure) après l'autre (épaule postérieure) (fig. 9),
    - soutenir le corps du nouveau-né avec les mains placées sous ses aisselles au cours de sa sortie (fig. 10).

      Le nouveau-né, recouvert de liquide amniotique et du sang de la mère, est particulièrement glissant et doit être maintenu fermement (fig 11).

      Ne jamais tirer sur l'enfant et le cordon ombilical.
- Noter l'heure de naissance.
- Prendre en charge le nouveau-né (voir ci-après).
- Surveiller la mère jusqu'à la délivrance.

NB : Dans de rares cas, l'accouchement peut se faire par le siège et non par la tête. Dans cette situation :

- demander un renfort médical en urgence absolue,
- faire pousser pendant les contractions,
- laisser l'accouchement se faire sans toucher le nouveau-né.

[1] La description correspond à la présentation la plus fréquente de l'accouchement, l'accouchement en présentation céphalique.



Figure 4 : Installation de la parturiente



Figure 5 : Position pendant la contraction utérine

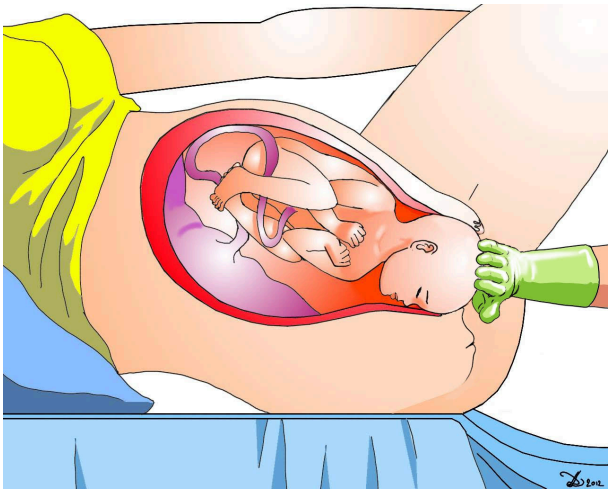


Figure 6 : ralentir la sortie avec le plat de la main

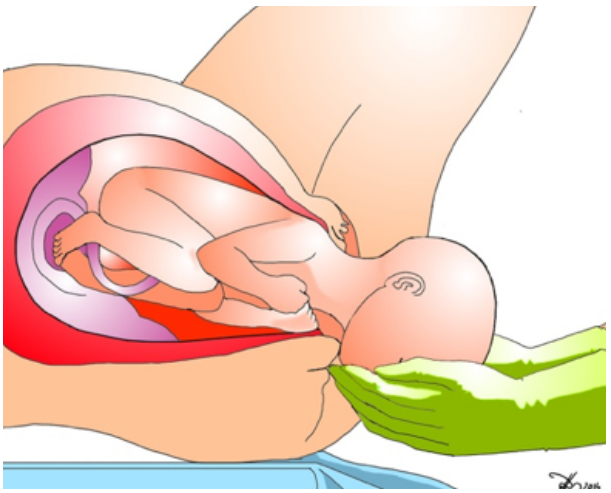


Figure 7 : ne pas s'opposer à la rotation de la tête

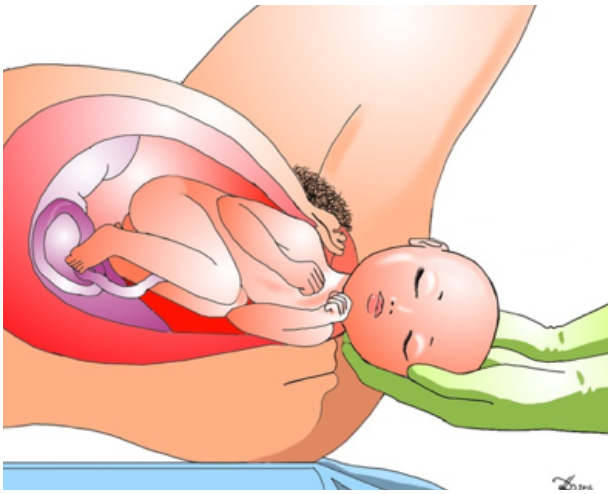


Figure 8 : la tête effectue une rotation d'un quart de tour

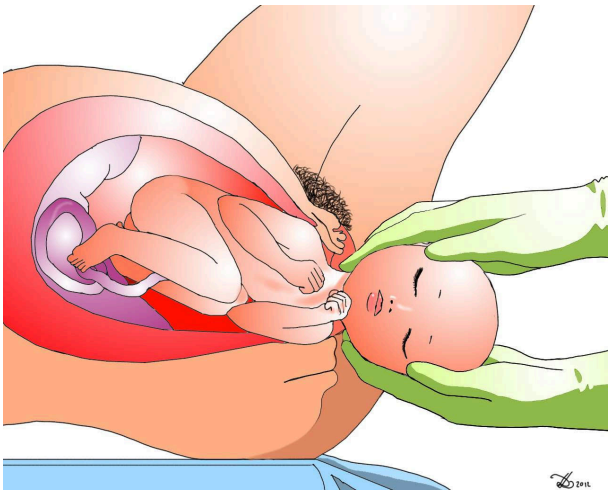


Figure 9 : accompagner le dégagement des épaules

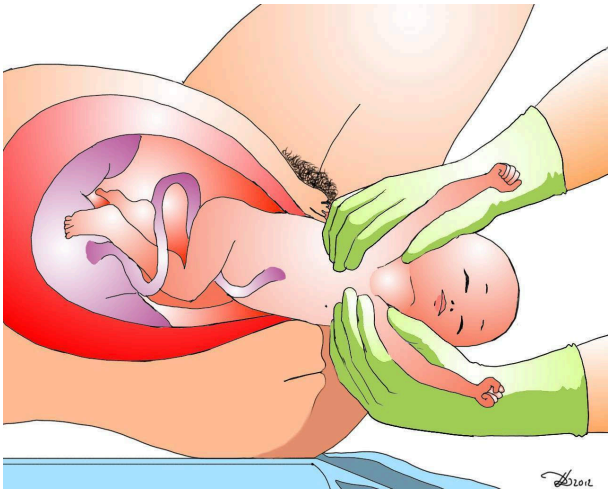


Figure 10 : *placer les mains sous ses aisselles*

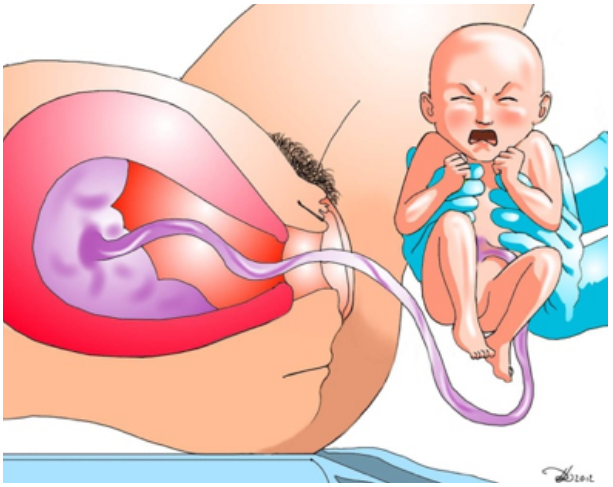


Figure 11 : *le maintenir fermement*

L'accouchement est déjà réalisé à l'arrivée de l'équipe.

- Prévenir immédiatement le centre 15.
- Demander l'heure de la naissance.
- Clamper puis couper le cordon (Fiche V-E-6).
- Réaliser simultanément (équipe secouriste) un bilan de la mère et du nouveau-né (Fiche III-C et III-D).
- Transmettre le bilan pour obtenir un avis médical (Fiche III-F).
- Prendre en charge la mère, la surveiller et l'assister pendant la délivrance (voir ci-dessus).
- Prendre en charge le nouveau-né (voir ci-dessus et Fiche IV-B-8 si le nouveau-né présente une détresse).

Dégagement d'une circulaire du cordon

Il arrive parfois que le cordon ombilical fasse un ou plusieurs tours autour du cou de l'enfant, c'est une circulaire du cordon.

Lors de l'accouchement, dès que la tête tente de sortir, la tension du cordon ombilical devient telle que la progression ne peut plus se faire et chaque contraction utérine étrangle davantage le nouveau-né (fig. 12).

Lorsque l'on aperçoit le cordon ombilical autour du cou du nouveau-né, il est nécessaire de :

- Maintenir la tête, sans chercher à la refouler, pour éviter cette tension extrême.

Si le cordon est lâche :

- Dégager le cordon en le faisant passer au-dessus de la tête (fig. 13).

Si le cordon est serré :

- Poser deux clamps sur le cordon en deux endroits séparés de 2 à 3 cm, directement au niveau du cou de l'enfant (fig. 14). Les doigts du secouriste sont en protection entre le cordon et le nouveau-né afin de ne pas le blesser.
- Sectionner prudemment le cordon entre les deux clamps (fig. 15).

Bien maintenir l'enfant après avoir coupé le cordon, car le plus souvent la sortie du nouveau-né est très rapide.

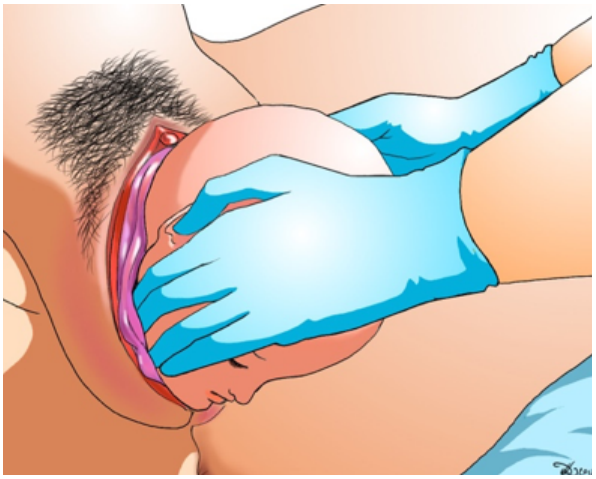


Figure 12 : circulaire du cordon

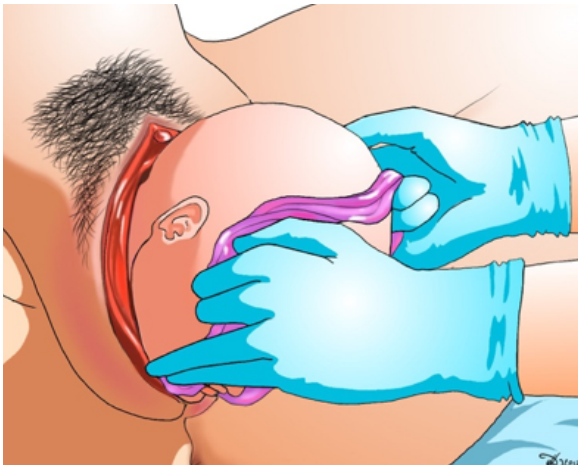


Figure 13 : dégager le cordon au-dessus de la tête

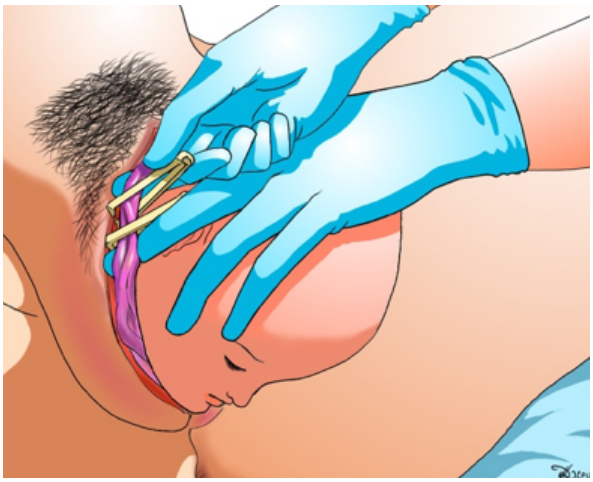


Figure 14 : poser 2 clamps sur le cordon au niveau du cou

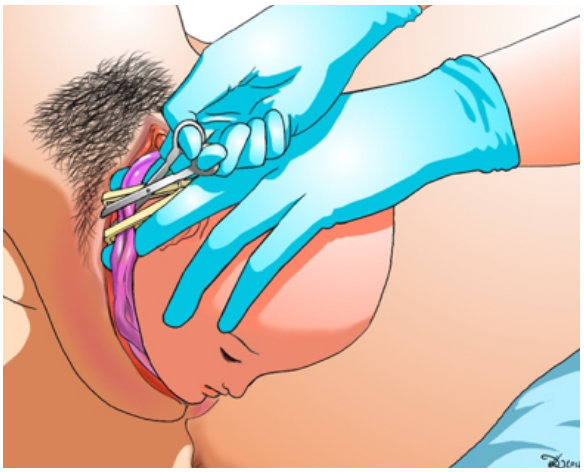


Figure 15 : sectionner le cordon

Prendre en charge le nouveau-né (conduite à tenir standard, nouveau né en bonne santé)

- Mettre une paire de gants à usage unique propre.
- Poser le nouveau-né à plat ventre sur le ventre de sa mère, peau contre peau, la tête sur le côté et bien dégagée.
- Apprécier :
  - son cri,
  - son tonus (mouvements spontanés des membres),
  - sa respiration,
  - sa couleur.

Le nouveau-né en bonne santé *présente une respiration et un cri vigoureux, un tonus vif, une coloration rapidement rosée (une cyanose initiale est normale, car la saturation en oxygène est basse. Cette*

cyanose disparaît habituellement en quelques minutes). L'existence d'une pâleur doit alerter les secouristes et être indiquée lors de la transmission du bilan.

- Clamper et couper le cordon ombilical au minimum après 1 minute de vie (Fiche V-E-6),
- Sécher par tamponnement la peau du bébé, à l'aide d'une serviette propre, sèche et tiède,
- Protéger le nouveau-né contre le froid :
  - protéger le nouveau-né des courants d'air,
  - couvrir la tête du nouveau-né avec un bonnet,
  - recouvrir le nouveau-né et la mère avec une serviette sèche et chaude puis avec une couverture isotherme.
- Surveiller le nouveau-né (Fiche III-C).

Lors de son transport, le nouveau-né doit être placé dans un dispositif sécurisé, prévu à cet effet..

Le nouveau-né présente une détresse à la naissance, *il ne crie pas, est hypotonique ou présente une ventilation anormale ou absente.*

- Appliquer la conduite à tenir du nouveau-né en détresse à la naissance (Fiche IV-B-8).

Réaliser la délivrance

La délivrance se fait le plus souvent en présence de l'équipe médicale. Toutefois en son absence il faut réaliser les actions suivantes :

- laisser sortir le placenta sans tirer dessus, ni sur le cordon ombilical en faisant pousser.
- recueillir le placenta dans une cuvette ou un sac plastique une fois expulsé. L'acheminer avec la mère à l'hôpital pour vérifier son intégrité.
- réaliser un massage utérin pour prévenir les hémorragies après la naissance (Fiche V-E-16) ;
- s'assurer de l'absence d'hémorragie extériorisée (Fiche IV-B-4). En effet, une hémorragie secondaire peut survenir après la délivrance.
- placer un pansement absorbant entre les cuisses de la mère.
- surveiller la mère (Fiche III-E) car une hémorragie secondaire peut survenir après la délivrance.

Devant une hémorragie de la délivrance :

- Appliquer la conduite à tenir devant une hémorragie extériorisée (Fiche IV-C-7).

Si le placenta ne sort pas au bout de 30 minutes après la naissance :

- Demander un avis médical et respecter les consignes.
  Le médecin régulateur ou la sage-femme du centre 15 peut vous demander de réaliser un massage utérin pour faciliter sa sortie et prévenir les hémorragies (Fiche V-E-16).